

BENZODIAZEPINES

Ιστορικό: Ελέγχουμε αν η λήψη των βενζοδιαζεπινών (BZDs) γινόταν και σε χρόνια τακτική βάση για θεραπευτικούς λόγους (*αγχώδεις διαταραχές, κατάθλιψη, διαταραχές ύπνου, κ.λπ.*). Συνήθως, η μεμονωμένη λήψη των βενζοδιαζεπινών δεν είναι θανατηφόρος, παρά μόνον σε περιπτώσεις πολύ υψηλών – per os – δόσεων, καθώς και σε υψηλή ενδοφλέβια χορήγηση. Ελέγχουμε επίσης αν υπάρχει ταυτόχρονη λήψη οιοπνεύματος, οπιοειδών ή βαρβιτουρικών. Αυτοί οι συνδυασμοί είναι θανατηφόροι ακόμα και σε λήψη μικρής δόσης βενζοδιαζεπινών. Θανατηφόρος υπέρβαση της δόσης είναι πολύ πιθανότερο να προκύψει με τα σκευάσματα βενζοδιαζεπινών βραχείας δράσης (*Αλπραζολάμη/Xanax, Τριαζολάμη/Halcion, Τεμαζεπάμη*).

Κλινική εικόνα: Οι κυριότερες δράσεις των Βενζοδιαζεπινών εκδηλώνονται από το ΚΝΣ (όπου συνδέονται επιλεκτικά με ειδικούς υποδοχείς των βενζοδιαζεπινών που εδράζονται στην α-υποομάδα των GABA υποδοχέων) με κεφαλαλγία, διπλωπία, οφθαλμοπληγία, νυσταγμός, μύση, δυσαρθρία, αταξία, αμνησία, υπνηλία, διαταραχές της νοητικής λειτουργίας, λήθαργο. Σπάνιες και παράδοξες αντιδράσεις της υπερδοσολογίας μπορεί να είναι βίαιη συμπεριφορά, οργή και παραλήρημα. Ο ασθενής με τοξίκωση, είναι επίσης πιθανό, να προσέλθει στο ΤΕΠ με μύση, βραδυκαρδία, διαταραχή της αναπνευστικής λειτουργίας, υπόταση και υποθερμία. Σε ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανισθούν αντιχολινεργικά συμπτώματα, όπως ξηροστομία, ταχυκαρδία, μυδρίαση και κατάργηση της κινητικότητας του εντέρου. Τα μικρά παιδιά και οι ηλικιωμένοι είναι περισσότερο ευάλωτοι στην κατασταλτική δράση των βενζοδιαζεπινών στο ΚΝΣ και σε επιπλοκές (*αναπνευστικό arrest, ραβδομύλωση, κ.ά.*).

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Σε ληθαργικό ή σε κωματώδη ασθενή αξιολογούμε αρχικώς τον αλγόριθμο A-B-C-D-E. Ελέγχουμε ζωτικά σημεία (BP, HR, RR, SpO₂) και το επίπεδο συνείδησης (GCS ή AVPU).
 2. Βασικό μέλημα - ειδικά στον κωματώδη ασθενή - είναι η αναπνευστική υποστήριξη και ο επαρκής αερισμός, για αυτό χορηγούμε O₂ στα 6-12 lt/min, με μάσκα Venturi (28-40%).
 3. Τοποθετούμε 3way ενδοφλέβια γραμμή για χορήγηση 1 lt NaCl 0,9% ή R/L (στάγδην).
 4. Κατά την παραμονή του ασθενούς στο ΤΕΠ ελέγχονται συνεχώς (monitoring) τα ζωτικά σημεία, η καρδιακή λειτουργία (ΗΚΓ-ρυθμός) και η νευρολογική εικόνα (GCS/AVPU).
 5. Αν δεν έχουν παρέλθει περισσότερες από 2 ώρες από τη λήψη της ουσίας και ο ασθενής διατηρεί καλό επίπεδο συνείδησης (GCS:14-15), τότε επιχειρούμε την πρόκληση εμέτου. Αποφεύγουμε τη χορήγηση Ιπεκακουάνας, αλλά εάν αυτό κριθεί απαραίτητο και ως μόνη λύση, τότε χορηγούμε 30 ml σε ενήλικες και 15 ml σε παιδιά, μαζί με 2-3 ποτήρια νερό.
 6. Στις πρώτες 4 ώρες από την τοξίκωση μπορεί να γίνει έκπλυση στομάχου μέσω καθετήρα Levin ή/και να χορηγηθεί **ενεργός άνθρακας** (1 fl. Toxicarb 250 ml, δόση: 1 g/kg ΒΣ).
 7. Η χορήγηση καθαρτικού θεωρείται πλέον αμφιλεγόμενη πρακτική και δεν συνιστάται.
 8. Χορηγείται ενδοφλεβίως **Φλουμαζενίλη (Anexate)**, είτε με απευθείας iv-bolus έγχυση 0,2 mg = 2 ml σε 15 sec, με επανάληψη της δόσης ανά 60 sec, έως συνολικής δόσης 1 mg, είτε σε συνεχή στάγδην έγχυση (2-4 amp. σε 1000 ml ορού, με ρυθμό 0,5 mg/h) λόγω της μικρής διάρκειας δράσης της, για αποφυγή επιβραδυνόμενης αναπνευστικής καταστολής. Η Φλουμαζενίλη χορηγείται μόνο όταν είμαστε σίγουροι για μεμονωμένη υπερδοσολογία Βενζοδιαζεπινών και όχι σε λήψη κοκτέιλ φαρμάκων (*απόλυτη αντένδειξη σε τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά*) ή σε υποψία αυξημένης ενδοκράνιας πίεσης από τραύμα (ΚΕΚ) ή όγκο.
- ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση σε συνολική δόση 3-5 mg Φλουμαζενίλης, τότε πιθανότατα οι Βενζοδιαζεπίνες δεν αποτελούν την κύρια αιτία καταστολής του ασθενούς.
9. Επί επιδεινώσεως ή μη ανταπόκρισης στη θεραπευτική αγωγή, διακομίζουμε τον ασθενή στο νοσοκομείο, για νοσηλεία και πιθανώς για ψυχιατρική εκτίμηση και αντιμετώπιση.